

Pat.-Nr.: 8237

Name: Derikael Thomas

Datum	Leistungsziffer	Diagnose
4.17.	↓	Fortsetzung 08.02.23:
645	✓	Sono-Duplex Carotiden + SD: Intima: 0,26 StV: 44,2 re. SD: 8,0cm li. SD: 12,0cm
04		bp: Jodid 100 NS 11
08.02.23	14 ⁴⁵	OS bds
1.9.	✓	Op. de zenuwen bds
1565	1578	
10.02.23		Hepatitis - Serologie nachgefordert
12.		

Pat.-Nr.: 8237

Name: Beniffel, Thomas

Datum	Leistungsziffer	Diagnose
9.08.21	14:15	OS bds. gespült Medivitamin im v. Pexis Hörtest ab 3
1565-1578	✓	
1403-CO		
6.02.23	16:00	Check up & HKJ
Anamnese Familienanamnese ☐ negativ Herzinfarkt ☒ nein ☐ _____ Schlaganfall ☒ nein ☐ _____ Tumorerkrankung ☐ nein ☐ Oma beide. Tante Lunge Darmkerkrankung ☒ nein ☐ _____ Nikotinabusus: ☐ ja ☒ nein ☐ Exraucher Gyn. VS _____ Uro. VS _____ Colo ☐ nein Wann? _____ Check up Privat ☐ Größe 189 cm ☐ Gewicht 79 kg ☐ RR ☐ P /min, O2 /min ☒ EKG } bei Bespr. - TE bitte mitmachen ☒ KAI } wg. Personalmangel ☐ Impfstatus ☐ Medikamentenplan abgleichen (PC-Doku) ☒ C9 CB. ☒ iFOBT mitgeben ☒ Colo gemacht? ☒ Lufu 075.272 ☒ BE: P-Labor, Selen ☒ Sono Abdomen		
M		HNO: re. Cerumen obdoliens TE OS rechts Abdomen: weich, & res.
M		Bspr. TE bei Fr. Dr. lt. Chef

Pat.-Nr.: 8237

Name: Deniffel Thomas

Datum	Leistungsziffer	Diagnose
25.08.21	1000 (228.3)	
7-626-3	Luft simult. o.B.	> Schnelltest ? vollständig geprüft
605-605a	Hörtest Sehtest Farbsichttest o.B.	D mit Brille
1403-1228	MR 120/80 mmHg M O ₂ 98 % P. 43 /min	Größe 190cm Gewicht 90kg max. 270kg
602		
682		

Wert	Minuten	RR	HF
75	1	120/80	90
100	2	120/80	99
125	3	130/80	107
150	4	140/80	117
175	5	150/90	134
200	6	160/90	145
225	7	160/90	153
250	8	170/90	163
275	9	190/90	169
25	11	170/80	112
	13	150/70	101

ASL 1 w. Früh Jela Lysel

Ar. e Herz, e Brust

TE Ohrspülung + Hörtest

Pat.-Nr.:

8237

Name:

Deniffel Thomas

Datum	Leistungsziffer	Diagnose
30.4.21	12:15	Sono 20ns. + 1x Medivitan
424		<u>Sono DIAG:</u> Pleura: Ø Erguss, Hohlvene: Ø gestaut, Herz: schöne Bewegung Klappen: zart, Mitralklappe: Ø Verkalkung, Herzgröße: schön geteilt Ø Wandbewegungsstörungen, Pumpfunktion EF 50%. 77% mittlere Herzenebene Druck, Septum: 15mm zarte Aortenklappe fast Ø sichtbar, Ø Wandbewegungsstörung, gute Pumpfunktion
2521		an 1 Medivitan i.m. v. Praxis
13.5		Tel: Speziallabor z.B. A. Zolicki noch zu empfehlen, → ebenfalls Blutabnahme → d. dann Besprech.-termin in Bttr. Jr.
04.05.21	7:30	Medivitan Ø erschauen
11.5.21	7:30	<u>5. Medivitan</u> i.m. v. Praxis/jc
2521		Besprech. Blutwerte und vorher Prozedere
18.5.21	7:30	Spritze 1x Medivitan i.m. (6.)
25.05.21	8:15	1x Medivitan i.m. Ø erschauen

Privat

Deniffel

Thomas

Ellenberg 116

06.04.94

Name: _____

Behandlungs-Verlauf

Pet. Nr. D-87499 Wildgoldsried

Diagnose

21.04.21

21.4.21

815

Spritze

Medication i.m. von Praxis

Havrix Impf bringt Pat mit

25211

✓

Ich willige ein, zur Injektion

Havrix 1440
Ch.-B.: AHAVB995AM
Verw. bis: 08.2021

Hep. A i.m.

375 Havrix

.....
Allergieaufklärung etc. erfolgte
.....

Pat.-Nr.: 8237

Name: Deniffel, Thomas

Datum	Leistungsziffer		Diagnose
15.4.21		11:00 (Besprechung lt chef)	
			31
		RR 130/80	
		O ₂ 94% P 13 l/min	
		Coz / w/ Pp. Harnix 1440 (jetzt 1x) (um ^{erst 1x} 27 Jahr)	
25.2.21		✓ Mit Labor 2x IFOBT (Proben schon b. uns im Labor)	
20.10			
4.01		✓ Bes. Impfstatus	
Co		Dg: dyspnoe, toxisch, allerg. Hauterkrankung eingepr. Beratung	
		w/ Pp: Dermoxin Creme	
		Dg: Hyperhomocysteinämie, α-Lipoprote	
		w/ Medication im a. Praxis	
		5x IE für Medication	
		Sonographie Abdomen (33042)	
		Leber: ☒ o.p.B. ☐ etw. auf Fettleber	
		Nieren: links ☒ o.p.B. ☒ kein Harnstau	
		rechts ☒ o.p.B. ☒ kein Harnstau	
		Pankreas: ☒ o.p.B. ☐	Leber u. Niere selbe Dicke
		Gallenblase: ☒ o.p.B. ☒ keine Wandverdickung	
		☐ Steine/Gries ☒ Murphy negativ	
		Milz: ☒ o.p.B. ☐	
		Große Gefäße: ☒ o.p.B. ☐	
		Harnblase: ☒ o.p.B. ☐	
		Ergüsse: ☒ keine ☐ Pleura	
		☐ Aszites	
		82 UKG TE b. Frau Dr.	

Pat.-Nr.: 8237

Name: Sniffel Ranao

Datum	Leistungsziffer	Name:	Diagnose
8.4.2021	HKS + VS + Chole	Beruf: Programmier	
	Vorsorge US	Eintrag 9.3	
	Temp 36,8	Kurzfrist u. Anamnese	
		Tumoranamnese	
		- aktuelle	
602	Jg.: - Positive Familienanamnese Tumor		
KAI	Oma Mutter → erst. Mamma NPL (9/2020)		
	Opa Mutter → auch Tumor, Lokalisation? (2019)		
	Oma Vater → Zungenkarzinom b. Nikotinabusus (2017)		
IFOB	- Z.n. Nephrolithiasis		
605-	Check up Privat		
605a	Größe 180cm Gewicht 100kg		
	RR 118 / 68 mmHg		
	P 88/min, O2 98% P 56/min		
LaborP.	EKG		
	KAI		
	Impfstatus → Impfstatus 2016 vollständig abgelesen		
	Medikamentenplan abgleichen (PC-Doku) keine Dauermedis		
	C9 o.B.		
	iFOBT mitgeben		
	Colo gemacht?		
	Lufu		
075.164	BE: P-Roxon, Selen, Testosteron, Glamy Hoch, Glamy pro, Barliose, Mg		
4/7-645	Cor o.B., Puls regelmäßig, NG		
Co	Pulmo frei		
	Pat. Nichtraucher		
	klinisch unauffällig		
	Rekt. US: o.B.		
	HKS unauffällig		
	TE m		
	ZUS Bespr.		
	(Zeit nah)		
	a		
	lex-Sonographie Carotiden (33050)		
	Intima: 0,3 mm; SV: 24,8 cm/s		
	Arteriosklerose		
	arteriosklerotischer Gefäßstatus		
	Sonographie Schilddrüse (33012)		
	mm (B/D/L) Vol.: ml		
	homogene echonormale feingranuläre Binnenstruktur,		
	n Herdbefund		
	noten		
	s: mm (B/D/L) Vol.: ml		
	homogene echonormale feingranuläre Binnenstruktur,		
	n Herdbefund		
	noten		
	Präventiv jährlich 200ff		
	Kontrolle: □ ¼ jährlich □ ½ jährlich □ S: 1-0-0		

Pat.-Nr.:

8237

Name:

Demiffel Thomas

Datum

Leistungsziffer

Diagnose

21.1.21

922

Tel. Pat. TE nur OP-Vorbereitung
angeboten, Pat. war schon b. Verleasant

Wj. OP am 16.2., klärt es aber nochmal
ab ob weit. US nötig sind, meldet sich
bei Bedarf

① Plantarfasziensystem Grund geben 6 D. 10 Fsp.

22.02.21

11:15

2. n. KH, am Donnerstag entlassen
worden, V3 + Bespr. weiteres
Procedere

8/20/21

① Dienstag früh CP gelöst

→ Ø 4 abh. 11.

Besprechung KH-Bericht

Pat. seit gestern 4-frei

Kramer-Verband durch Fr. Dr.

① TE Ende der Woche bei Fr. Dr. in
Sprechstunde Vbw.

Wunde schaut gut aus,
reizlos

① Ruptur plantare Platte MTP 2 mit
sekundärem Knochenodem zweites
Grundglied links (Fuß)
rez. Synovitis MTP 2
2. n. OP

Ø Heparin-Therapie notwendig H
Arztbrief

Pat.-Nr.:

8237

Name:

Deniffel Thomas

Datum	Leistungsziffer	Diagnose
5.4.19	16:40 OS	Ø Pat nicht erschienen!!
6.5.19	RG 863/17 v. 8.10.17	an neue Anschrift gedruckt!
27.01.20	10:30 Knieschmerz	
	abgesagt	
15.04.20	14:00 OS	
1565 1578	bds Cerumen obturans bds	
4631 20	12.7.20	
21.7.2020	HRT an INTER-US	
	am 27.7.20	
	an Pat.	
	zum gegenseitigen	
16.10 - 20	Antrag Darter Versicherung	
26.10.20	1. Einweisung HST/MSD	
	an VS gest.	
18.11.2020	HRT INTER-US	
8.11.20	am 23.11.2020	- an VS gest.

Pat.-Nr.:

Name:

Deniffel Thomas

Datum

Leistungsziffer

Diagnose

252 ² Dyz
m

Tortsetzung 25.8.17

Stenokardie bei BWS Syndrom

651-

HNO / CIP O.B.

657

1 Dynastat i.m. } a. Praxis
 1 Medivitan i.m. }
 EKG → SISI, STI Typ

21.09.17

8:00

Ø gekommen

28.09.17

8.10

Check up Privat

- ☒ Größe 190cm
- ☒ Gewicht 87kg
- ☒ RR 100/60
- ☒ P 55 /min, O2 98 /min
- ☒ EKG 25.8.17
- ☒ KAI
- ☐ Impfstatus
- ☒ Medikamentenplan abgleichen (PC-Doku)
- ☐ C9
- ☒ iFOBT mitgeben
- ☒ Colo gemacht?
- ☒ Lufu
- ☐ BE: Gluc, HDL, LDL, Chd, Harnsäure, Kreat. Bl. BB
- ☒ Sono Abdomen

A. inter. Systemerkrankung

17.800

602

637-643

mm

605-605a

075 963

Labor

1565

1578

HNO: Gerumen abwärts rechts und links
 Rachen eng / verschl. E

Ger: Ø NG, HT ren + rhythmisch
 Pulma: fr, satenged, Ø RGS
 WS: o.B. Ø KS

Cutis: Acne vulgaris comedonica am Rücken

Chroptylung betr. Gerumen bds.

✓ Rp. Epiduo

863/17

8.10.17

Pat.-Nr.:

Name:

Beniffel Thomas

Datum

Leistungsziffer

Diagnose

17.3.17 10:00

✓

pat. rief an und meinte er sei gerade in Spanien und schreibt dort seine Bachelorarbeit. Er musste allerdings die letzte drei tage wg Nierensteinen und Mikrhämaturie ins Krankenhaus und konnte arbeit nur bedingt fertigstellen wg Zeitmangel. in Spanien ist es allerdings so das die ärzte dort keine AUs ausstellen er hat lediglich eine bestätigung bekommen das er von mittwoch-freitag im KH war. Schule braucht jetzt aber AU.
Laut Chef können wir AU schon ausstellen er soll uns vorher die Bestätigung faxen.

20.03.17 10:00 → Patient meldet sich wenn er Attest braucht

74117 16.4.17

24.04.17 10³⁰ durch d. Pd. seine Rechnungsumlagen sind abbezahlt gekommen

Pd. bitte um nochmalige Zurechnung v. Rechnung
10.01.17 + 16.04.17

Danke am 25.4.17 grl. C.E

15.8.17 19:00

Attest für Befreiung von Prüfung morgen

1-8-✓

• Attest Prüfungsunfähig

2010

Sono Attest: z.n. Nierenstein

↓

Narbige Phimose bei ca. 6 Wochen ruher weiter mit Dermoxil - Creme

Privat

Deniffel

Thomas

Haldenweg 7A

06.04.94

Name:

Behandlungs-Verlauf

D. 87499 Wildpoldsried

Diagnose

03.02.17

03.02.17

1830

Rp: Twinrix N₁ 1 Spritze
Dakorad N₁ 2 x 1 Stk.

375

Twinrix Erwachsene
Ch.-B.: AHABB346AE
Verw. bis: 07.2018

57419
001-03

A

09.01.17

9:00

H Chef Pat. fliegt
Nachmittags nach Spanien

✓ 8

Sono d. pers. Entesepathie ^M Ansatz Rektus - Abdominis re. u. Kom
~~Handstüb~~ re. , Aductoren re. Beulen ^{pubis}

252² Dyn

M

Sono Adel

Sono = O.B.

① Forttheropathie Adhäsionen am OS
OS pubis re.

267 TX

✓ Dynastat im von Praxis
Medunitan im von Praxis

Trinico (Kylsiphil)

✓ TE Antwort für Spitz Dynastat + Medunitan

1198/16 10.1.17

1.1.17

9:30

Spitze

17. 252² ① Medunitan im (v. Praxis)

1 7 Kontaklebran li. Ellenbogen (Dr. Scherzgerken)

3.2.17 o.T 830 Uhr. Veldner bel

✓ auf 35 utop → Hcent cussch

252³ n

② medunitan im von Praxis

PC: Petrich David
mit Wölfler, Christoph

Seit 1.12.16 Privat - Versichert, vorheriger
Hausarzt Dr. Mayer (Wildpoldsried)

19.12.16

19:30h

1.8. ✓

Ober ~~Becken~~ bei
Vorhergesagtem

Seit 3/16 4 (ist 12) li
bei bei Abduktion; → wunde schmerzen

298

Labo P

(b)

Reiz: Gucken, Blenden → Rucke → Entzündung
mit Rötungen Bild, (Dauer ca 10-15 min)
5. 11 u. Dez. 16

267 TX

^{Montag}
✓ PCR auf Herpes Genitales

Reflex: Tinnit + Kollaps

(Og)

rote Adduktoren-
syndrom

mit Enthesopathie Os pubis
~~Schütteln~~ & schmerzhaft bei

075 645

✓ BE P-Labor, Chlamydien hoch, PTHA-Test

✓ Rp. Decoderm in
Tubtop - Gel

Termin am Montag
9.01.17